

TEMA 5.12 • OFTALMOLOGÍA

vicios de refracción

PERFIL EUNACOM 6.02.2.004
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Resumen: Perlas de los Síndromes de Pérdida Súbita de la Visión

La siguiente es una guía de integración y diferenciación para reconocer eficientemente frente a preguntas clínicas (EUNACOM) o urgencias, cuál de los síndromes indolores y silentes visuales súbitos es el más probable enfrentando la etiología y el factor de presentación base patognomónica de cada uno con su tiempo base particular de instauración progresivo general per se.

Temporalidades Clásicas Biológicas

1. **Pérdida en Segundos de Forma Fulminante (Tipo "Switch-Apagón Masivo"):** - **Oclusión de la Arteria Central de la Retina** (Origen embolicardíaco o aterotrombótico). - **Neuropatía Óptica Isquémica (NOIA)** (Origen isquémico o arteritis). 2. **Pérdida en Minutos y Pocas Horas Intermedias:** - **Hemorragia Vítrea** purulenta (Común en Diabéticos crónicos severos y proliferativos con extravasación activa aguda general de cámara y ojo). - **Trombosis de la Vena Central de la Retina**. 3. **Pérdida en Instalación Sostenida Subaguda en Horas a Pocos Días:** - **Neuritis Óptica** per sé de etiología autoinmune activa profunda. - **Desprendimiento Quirúrgico de la Retina** (con antecedente clásico arrastrado gradual de base o trauma de base).

Diagnóstico Diferencial de Claves Semiológicas Esenciales

TABLA 5.12.1: SIGNO CLAVE EUNACOM VS PATOLOGÍAS ALTAMENTE PROBABLES SUGERIDAS POR FRECUENCIA	
SIGNO CLAVE EUNACOM	PATOLOGÍAS ALTAMENTE PROBABLES SUGERIDAS POR FRECUENCIA
Defecto Pupilar Aferente (Pupila DPA - Marcus Gunn franco general)	Neuritis Óptica (principal) y Neuropatía Óptica Isquémica neurológica isquémica franca. (Puede aparecer relativamente tardíamente en desprendimiento retinal extendido y en el infarto masivo oclusivo oclusión arterial).
Antecedente Personal Reumatológico de Esclerosis Múltiple Activa y Jóvenes Mujeres	Patognomónico y clásico directo previsor asociado inconfundible de Neuritis Óptica Infecciosa Autommune .
Pérdida Total e Íntegra del Reflejo Rojo Pupilar en inspección básica (y fondo inobservable oscuro generalizado)	Fuertemente orientativo en el interrogatorio inicial en el paciente y patognomónico agudo primario de Hemorragia Vítrea Generalizada profunda y desorganizada intraluminal.
Presencia Temprana Reportada de Alarma en Visión de Entopsias y precursores Flashes de destellos blanquecinos persistentes (Fotopsias)	Muy preeminente característico en las fases agudas y en tracción activa preclínica y clínica inicial general del Desprendimiento Evolutivo Quirúrgico de la Retina patológico subyacente e inestable subagudo.

| **Anciano Polimórbido Crónico relatando Cefalea Unilateral Pulsátil Persistente Severa Reciente Temporal que avanza rápido sumando Claudicación al Masticar Crónica matutina** | Es la definición clásica de la vasculitis autoinmune granumatulosa profunda (Arteritis generalizada de la Temporal de Horton Celular) vinculada en este campo trágico general por isquemia terminal pura a producir ceguera final como **Neuropatía Óptica Isquémica Arterítica Severa Aguda y Terminal general.**|

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un joven de veinte años consulta porque no puede leer el pizarrón en clases pero no tiene problemas para leer libros de cerca. Al examen la agudeza visual de lejos está disminuida y mejora significativamente al mirar por un agujero estenopeico. ¿Cuál es el diagnóstico y el tipo de lente corrector?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para vicios de refracción. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La miopía tiene el punto focal antes de la retina por ojo grande; ve mal de lejos, se corrige con lentes biconcavas negativas.
- La hipermetropía tiene el punto focal detrás de la retina por ojo pequeño; ve mal de cerca, se corrige con lentes biconvexas positivas, y predispone al glaucoma agudo.
- El astigmatismo tiene córnea irregular; la imagen se distorsiona de cerca y lejos, se corrige con lentes cilíndricas.
- La presbicia aparece a partir de los cuarenta años por endurecimiento del cristalino, produce dificultad para ver de cerca, se corrige con lentes para lectura.
- La prueba del agujero estenopeico es clave: si la visión mejora al mirar por un agujero pequeño, el problema es refractivo y no orgánico.
- Los bifocales en adultos mayores con presbicia aumentan el riesgo de caídas porque generan una zona de distorsión visual al caminar.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (VICIOS DE REFRACCIÓN)

PREGUNTA 1

Un joven de veinte años consulta porque no puede leer el pizarrón en clases pero no tiene problemas para leer libros de cerca. Al examen la agudeza visual de lejos está disminuida y mejora significativamente al mirar por un agujero estenopeico. ¿Cuál es el diagnóstico y el tipo de lente corrector?

- A) Hipermetropía; lentes biconvexas de poder positivo
- B) Miopía; lentes biconcavas de poder negativo
- C) Astigmatismo; lentes cilíndricas
- D) Presbicia; lentes de lectura
- E) Ambliopía; oclusión del ojo sano

PREGUNTA 2

Una mujer de cuarenta y cinco años consulta porque en los últimos dos años tiene dificultad progresiva para leer el periódico y debe alejarlo para poder enfocar. La visión de lejos es normal. No tiene antecedentes oculares relevantes. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A) Miopía tardía; lentes biconcavas negativas
- B) Degeneración macular; seguimiento con oftalmólogo
- C) Presbicia; lentes para lectura o bifocales
- D) Glaucoma crónico; tonometría y campimetría
- E) Hipermetropía; lentes biconvexas positivas

PREGUNTA 3

Un paciente hipermetrope de cincuenta años consulta al servicio de urgencias con dolor ocular intenso, visión borrosa, halos de colores y náuseas. ¿Por qué la hipermetropía es un factor predisponente para el cuadro que presenta este paciente?

- A) Porque los hipermétropes tienen presión intraocular crónicamente elevada
- B) Porque el ojo hipermetrope es más pequeño y tiene el ángulo iridocorneal más estrecho
- C) Porque los hipermétropes usan lentes de poder positivo que distorsionan el humor acuoso
- D) Porque la hipermetropía produce degeneración del nervio óptico con el tiempo
- E) Porque los hipermétropes tienen córneas más delgadas que facilitan el cierre angular

RESUMEN: VICIOS DE REFRACCIÓN

Los vicios de refracción son las ametropías, es decir, las alteraciones en la capacidad del ojo de enfocar correctamente la imagen en la retina. Son la causa más frecuente de disminución de la agudeza visual en la población general y su corrección con lentes es uno de los procedimientos más comunes en la práctica médica. La miopía es el defecto refractivo en que el punto focal cae antes de la retina. Esto ocurre porque el ojo es demasiado grande o la córnea tiene demasiada curvatura. El miope ve bien de cerca pero mal de lejos. Se corrige con lentes biconcavas de poder negativo, expresadas en dioptrías negativas. La hipermetropía es el defecto opuesto: el punto focal cae detrás de la retina porque el ojo es pequeño o la córnea tiene poca curvatura. El hipermetrope ve mal de cerca pero mejor de lejos, aunque en casos severos también puede ver mal de lejos. Se corrige con lentes biconvexas de poder positivo. Un punto importante es que la hipermetropía predispone al glaucoma agudo de ángulo cerrado porque el ojo más pequeño tiene el ángulo iridocorneal más estrecho. El astigmatismo se produce por una córnea o cristalino con curvatura irregular, no esférica, lo que produce una imagen distorsionada tanto de cerca como de lejos. Se corrige con lentes cilíndricas. La presbicia o vista cansada es el déficit de acomodación que ocurre a partir de los cuarenta años por endurecimiento del cristalino. Produce dificultad progresiva para ver de cerca. Se corrige con lentes para lectura o bifocales. Un truco diagnóstico importante es la prueba del agujero estenopeico: si la visión mejora al mirar por un agujero pequeño, el problema es refractivo y no orgánico.